新病理システムにおける検体照合機能導入の有効性の検討

◎河嵜 優菜[1)]、青木 亮吾[1)]、成瀬 諒太[1)]、伊藤 里紗[1)]、丹羽 理代子[1)]、後藤 美香[1)]
岐阜市民病院[1)]

【背景】病理検査における検体取り違えは、診断結果に影響を及ぼす可能性があり、医療安全上重要な課題である。病理検査では複数の工程を経て標本が作製されるため、検体・ブロック・スライドの識別操作が多く、ヒューマンエラーが発生し易い。当施設では 2024 年に新病理システムを導入し、受付・切り出し・薄切工程におけるバーコードを用いた検体照合機能の有効性を検討した。

【方法】検体照合機能導入前 10 年間(2014 年~2023 年)及び導入後 2 年間(2024 年~2025 年)に発生したインシデントを後ろ向きに集計し、導入の有効性を評価した。対象は当院病理部門におけるインシデント報告とし、①受付②切り出し③包埋④薄切⑤提出の 5 工程におけるインシデント件数及び、この 5工程を検体照合機能導入の有無で分類した時のインシデント件数を比較した。

【結果】検体照合機能導入前後のインシデント件数を比較すると、①受付:2 件から 0 件、②切り出し:2 件から 0 件、③包埋:3 件から 0 件、④薄切:2 件から 0 件、⑤提出:2 件から 1 件であった。照合機能を導入した①受付②切り出し④薄切では、インシデントが無くなり、照合機能を導入していない③包埋⑤提出ではインシデントが残存した。

【考察】①受付②切り出し④薄切工程では、複数の識別対象を扱うため、目視確認のみでは確認漏れや取り違えが生じていた。検体照合機能の導入により作業が単純化し、作業者の注意力に依存していた確認作業がシステム上で担保され、ヒューマンエラーの低減に繋がったと考えられる。一方で、検体照合機能を導入していない③包埋⑤提出工程ではインシデントが残存しており、システム介入の有無がインシデント発生状況に影響した可能性があると考えられる。検体照合機能導入後 2 年しか経過していないため、今後もインシデント発生状況をモニタリングしていく必要がある。また、検体照合機能を導入していない工程についても、照合機能の追加・工程の見直しを行う必要がある。

【結語】検体照合機能は病理検査工程におけるヒューマンエラー低減及び医療安全向上に寄与した可能性が示唆された。

連絡先:058-251-1101 (内線:4030)